PEDIATRIC NURSING · MERGED LECTURE & BOOK SUMMARY

Accident *Prevention*

Injuries are the leading cause of death after one year of age — but most are preventable. The epidemiological model, the types of accidents, the three levels of prevention, and the nurse's six-role safety net.

Merged Summary · **Lecture Slides + Textbook Chapter** · *Pediatric Nursing Department · 2025–2026*

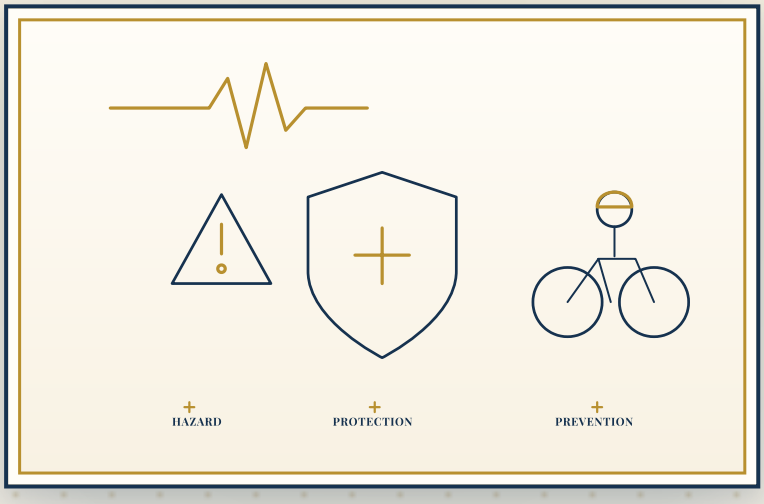


PLATE — *From hazard to protection: the nurse stands between the curious child and a dangerous world, turning every risk into a preventable event.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.

Introduction & Consequences of Accidents

Why Children's Safety Matters

— Healthy children are **vital resources** to ensure the future well-being of the nation.

— They are the **parents, workers, leaders, and decision-makers of tomorrow**; their health and safety depend on today's decisions and actions.

— Their future lies in the hands of those responsible for their well-being — so children's well-being should be a subject of **great concern**.

— Accidents are a **major public health issue** threatening health in every country (WHO, 2024).

— Childhood mortality constitutes a major public health problem and a major challenge facing the health system.

— **Accidents are the main cause of all deaths in children over one year of age and in adolescents.**

— **Injuries are the leading cause of death in children ages 19 and younger** — but **most child injuries can be prevented** (CDC, 2019).

— Parents and caregivers can play a **life-saving role** in protecting children from injuries.

The Global & Economic Burden

— It takes the lives of **4.4 million around the world/year ≈ 8% of all deaths**.

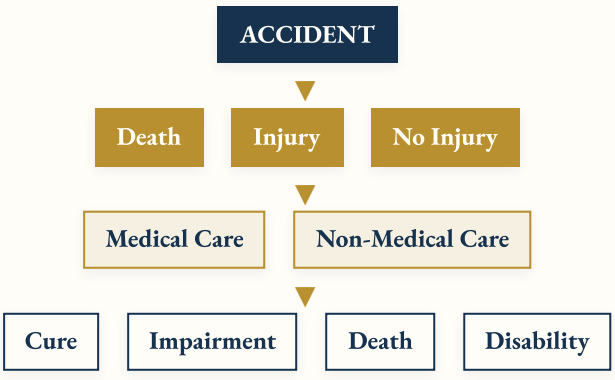
— For people aged **5–29 years, 3 of the top 5 causes of death are injury-related**.

— Injuries are responsible for an estimated **10% of all years lived with disability**.

— Injuries place a **massive burden on national economies**, costing billions of dollars each year in health care.

— Preventing injuries and violence facilitates achievement of several **Sustainable Development Goal (SDG)** targets.

Consequence of an Accident (Flow Chart)



لماذا سلامة الأطفال مهمة:

• الأطفال الأصحاء **موارد حيوية** لضمان رفاهية الأمة في المستقبل · هم آباء وعمالة وقادة وصناع قرار الغد.

• **الحوادث هي السبب الرئيسي لجميع الوفيات في الأطفال فوق سنة والمراهقين.**

• **الإصابات هي السبب الأول للوفاة في الأطفال حتى 19 سنة** — لكن **معظم إصابات الأطفال يمكن الوقاية منها.**
• الوالدان ومقدمو الرعاية يمكنهم لعب **دور منقذ للحياة.**

العبء العالمي والاقتصادي:
• تحصد أرواح **4.4 مليون شخص عالمياً سنوياً ≈ 8% من كل الوفيات.**
• في الأعمار **5-29 سنة، 3 من أعلى 5 أسباب وفاة مرتبطة بالإصابات.**
• الإصابات مسؤولة عن **10% من سنوات العيش مع الإعاقة** · عبء ضخم على الاقتصادات الوطنية.
• الوقاية تسهل تحقيق أهداف **التنمية المستدامة (SDG).**

عاقبة الحادث (مخطط التدفق):
• **الحادث** يتفرع مباشرة إلى ثلاث نتائج: **وفاة فورية** · **إصابة** · **لا إصابة.**
• عند حدوث الإصابة يتلقى الطفل إما **رعاية طبية** أو **رعاية غير طبية.**
• من الرعاية تخرج أربع نتائج محتملة جنباً إلى جنب: **الشفاء (Cure)** · **قصور (Impairment)** · **وفاة (Death)** · **إعاقة (Disability).**

Definitions — Accident, Injury & Related Concepts

TERM	DEFINITION
Accident	**Unintentional injuries** resulting from external physical forces or environmental hazards, occurring **without deliberate intent**, often leading to harm or impairment. Includes: falls, burns, poisoning, drowning, suffocation, traffic-related incidents.
Injury	Any **unintentional or intentional** damage to the body resulting from acute exposure to **thermal, mechanical, electrical, or chemical energy**, or from the **absence of essentials** such as heat or oxygen.
· **Unintentional injuries**	Harmful acts that occurred **without any intention** of causing damage to oneself or others.
· **Intentional injuries**	Injuries resulting from **purposeful harmful actions** upon oneself or others.
Impairment	**Losing part or all of a limb**, or having a defective limb, organ, or mechanism of the body.
Disability	The **loss or reduction of functional ability**.
Handicapping	The **disadvantage or restriction of activity** caused by disability **forever**.
Violence	A term describing the **exercise of force** to harm oneself or another person.
Injury Prevention	An effort to **prevent or reduce the severity** of bodily injuries caused by accidents **before they occur**; a component of safety and public health aiming to improve quality of life.

Classification of Injuries from Accidents

1
Minor Injuries Bruises, cuts, abrasions

2
Major Injuries Fractures, head trauma, burns

3
Fatal Injuries Drowning, severe burns, poisoning

⚠ **Injury vs Wound:** An injury may be caused by accident or aggression, but **until blood is drawn, it is not a wound. All wounds are injuries, but not all injuries are wounds. Injury is closed; wound is opened.** — N.B: Injuries are not "accidents"... **injuries can be prevented.**

التعريفات:
• **الحادث:** إصابات **غير مقصودة** ناتجة عن قوى فيزيائية خارجية أو مخاطر بيئية، تحدث **دون نية متعمدة** (سقوط، حروق، تسمم، غرق، اختناق، حوادث مرورية).
• **الإصابة:** أي ضرر **غير مقصود أو مقصود** للجسم ناتج عن تعرض حاد لطاقة **حرارية، ميكانيكية، كهربائية، أو كيميائية**، أو **غياب الأساسيات** كالحرارة أو الأكسجين.
• **القصور (Impairment):** فقدان جزء أو كل طرف، أو طرف/عضو/آلية معيبة.
• **الإعاقة (Disability):** فقدان أو انخفاض القدرة الوظيفية.
• **الـ handicapping:** الحرمان أو تقييد النشاط بسبب الإعاقة **للأبد.**
• **العنف:** ممارسة القوة لإيذاء النفس أو الآخر.
• **الوقاية من الإصابات:** جهد لمنع أو تقليل شدة الإصابات **قبل حدوثها.**

تصنيف الإصابات: بسيطة (كدمات، جروح، سحجات) · كبيرة (كسور، صدمات رأس، حروق) · قاتلة (غرق، حروق شديدة، تسمم).

الإصابة مقابل الجرح: الإصابة قد تنتج عن حادث أو اعتداء، لكن **ما لم يُسفَك الدم فهي ليست جرحاً. كل الجروح إصابات، وليس كل الإصابات جروحاً. الإصابة مغلقة والجرح مفتوح.** الإصابات **يمكن الوقاية منها.**

Incidence of Accidents & Injuries

Global Statistics (UN IGME)

— More than **5.0 million children under age 5** (including **2.4 million newborns**), along with **2.2 million children and youth aged 5–24 years — 43% of whom are adolescents** — died in 2020.

— Data gaps remain a serious challenge: almost **two-thirds of low- and middle-income countries (97 out of 135)** have no reliable mortality data in the past three years; only **40 countries** had high-quality national data for 2020.

— Injuries represent during infancy around **75% among those aged 1–2 years** and nearly **65% among 2–5 years old** children.

— Injuries are the overall leading cause of hospitalization: **over 23% of all admissions** and **28% of emergency department visits** in children under 15 years.

— **Unintentional home injuries** are a major cause of morbidity, mortality and disability in children **under five years** (Journal of Family Medicine & Primary Care, 2021).

Egypt Statistics

— Mortality rates: **18.1 deaths per 1,000 live births** under-five.

— Incidence of injuries was **higher among boys than girls** and in children aged **2–6 years**.

— The **five main causes** of injuries: **wounds, fractures, burns, swallowing a foreign body, and accidentally ingesting poison**.

— Injuries from **drowning, animal bites and sunstroke** mostly occurred in **rural children** (World Journal of Pediatrics, 2022).

Common Statistics by Cause

— **Falls:** the most frequent cause of **non-fatal** injuries among young children.

— **Burns:** occur mainly due to hot liquids, fire, and electrical sources.

— **Drowning:** a significant risk, particularly for children **under five**.

— **Poisoning:** results from exposure to household chemicals and medications.

— **Road Traffic Accidents (RTAs):** common in **older children and adolescents**.

الإحصاءات العالمية (UN IGME):
• أكثر من **5 مليون طفل تحت 5 سنوات** (منهم **2.4 مليون حديثو ولادة**) + **2.2 مليون طفل وشاب 5-24 سنة** (**43% مراهقون**) توفوا في 2020.
• فجوات البيانات: **ثلثا الدول منخفضة ومتوسطة الدخل (97 من 135)** بلا بيانات وفيات موثوقة؛ **40 دولة** فقط لديها بيانات عالية الجودة لعام 2020.
• الإصابات تمثل حوالي **75% في عمر 1-2 سنة** و**65% في عمر 2-5 سنوات.**
• الإصابات السبب الأول للاستشفاء: **أكثر من 23% من كل الدخول** و**28% من زيارات الطوارئ** تحت 15 سنة.
• **إصابات المنزل غير المقصودة** سبب رئيسي للمراضة والوفاة والإعاقة تحت **5 سنوات.**

إحصاءات مصر:
• معدل الوفيات: **18.1 لكل 1000 ولادة حية** تحت الخمس سنوات.
• الإصابات **أعلى في الأولاد** وفي عمر **2-6 سنوات.**
• **الأسباب الخمسة الرئيسية:** الجروح، الكسور، الحروق، بلع جسم غريب، ابتلاع سم بالخطأ.
• **الغرق وعضات الحيوانات وضربات الشمس** أكثر في **أطفال الريف.**

حسب السبب: السقوط أكثر سبب للإصابات غير القاتلة · **الحروق** من السوائل الساخنة والنار والكهرباء · **الغرق** خطر كبير تحت 5 سنوات · **التسمم** من الكيماويات المنزلية والأدوية · **حوادث الطرق** في الأكبر سناً والمراهقين.

The Epidemiological Model — Host, Agent & Environment

This model was developed for **better understanding and preventing accidents in children**. It includes three factors that interact together: **Host (child)**, **Agent (cause of injury)**, and **Environment (surroundings)**.

THE HOST (CHILD)

- Age
- Sex
- Race
- Genetic profile
- Previous diseases
- Immune status
- Religion
- Customs
- Occupation
- Marital status
- Family background

THE AGENT (VECTOR)

- **Biologic:** bacteria, viruses
- **Chemical:** poison, alcohol, smoke
- **Physical:** trauma, radiation, fire
- **Nutritional:** lack, excess

THE ENVIRONMENT

- Temperature
- Humidity
- Altitude
- Crowding
- Housing
- Neighborhood
- Water
- Milk
- Food
- Radiation
- Pollution
- Noise

I · The Host (5 Detailed Characteristics)

— **1 · Age / developmental level:** Children **under one year** are exposed to **accidental mechanical asphyxia** due to unsafe sleeping circumstances; other injuries are less common because of limited mobility. **Immaturity in motor skills and inexperience in safe exploration** increase the chance of injury. **The environment increases the chance of falls and suffocation during infancy.**

— **2 · Gender: Boys have more injuries than girls**; the **male death rate from injuries is twice that of females**. In Egypt, males tend to have more **out-door** injuries while females tend to **indoor**, due to behavioral differences (e.g., boys take greater risks in play — climbing higher, riding faster, complicated bicycle moves).

— **3 · Curiosity:** Children are **naturally motivated by curiosity**; they learn from touch, taste, sight, hearing and smell as they explore new experiences outside their rooms. **Parents need to provide a safe environment** to prevent injury.

— **4 · Peer pressure:** Contributes greatly to accident incidence; **competition and taking dares** can lead to injury in children trying to do one better than their peers, especially among **school age and adolescents**.

— **5 · Special needs:** Some children with special needs are at **increased risk** — e.g., **attention deficit disorder** or **high activity levels**, because of short attention span and inability to follow directions.

II · The Agent

The specific vehicle causing the injury is the agent or **"vector"**. The characteristics of the agent determine the **degree of potential for injury**: the design of a toy, the temperature of hot water in a home, the packaging of medicine, and the toxicity of poisons all influence the occurrence and nature of the event.

III · The Environment

PHYSICAL ENVIRONMENT

— Air · Housing · Water · Soil.

SOCIAL ENVIRONMENT (3 FACTORS)

— **1 · Socioeconomic level:** housing is one of the risk factors leading to major health problems in children.

— **2 · Time:** most injuries happen **at home between late afternoon and early evening**; in **summer during school holidays and weekends**; and at times of **stress** when routine changes or people are in a hurry.

— **3 · Place:** common site of accidental injuries under 15 years is the **home**; the **kitchen and bathroom** are the most dangerous places (cooking-related injuries/burns).

النموذج الوبائي (المثلث الوبائي): طُوّر لفهم ومنع حوادث الأطفال بعوامل ثلاثة: **المضيف (الطفل)** · **العامل (سبب الإصابة)** · **البيئة**.

أمثلة المضيف (11 عامل): العمر · الجنس · العرق · الملف الجيني · الأمراض السابقة · الحالة المناعية · الدين · العادات · المهنة · الحالة الاجتماعية · خلفية الأسرة.

أمثلة العامل (4 فئات): بيولوجي (بكتيريا، فيروسات) · **كيميائي** (سموم، كحول، دخان) · **فيزيائي** (رضوض، إشعاع، نار) · **غذائي** (نقص، إفراط).

أمثلة البيئة (12 عامل): درجة الحرارة · الرطوبة · الارتفاع · الازدحام · السكن · الحي · الماء · الحليب · الطعام · الإشعاع · التلوث · الضوضاء.

خصائص المضيف الخمس بالتفصيل:
1. **العمر:** تحت سنة يتعرضون للاختناق الميكانيكي العرضي بسبب ظروف نوم غير آمنة؛ عدم نضج المهارات الحركية يزيد خطر الإصابة. **البيئة** هي التي تزيد فرص **السقوط والاختناق** في الرضاعة (جملتان منفصلتان كما في السلايد).

2. **الجنس: الأولاد إصاباتهم أكثر، معدل الوفاة الذكري ضعف الأنثوي.** في مصر: الأولاد إصابات **خارجية** والبنات **داخلية**.
3. **الفضول:** دافع طبيعي؛ يتعلمون باللمس والتذوق والرؤية؛ **الوالدان مطالبان ببيئة آمنة**.
4. **ضغط الأقران: التنافس وقبول التحديات** يؤديان للإصابة، خاصة سن المدرسة والمراهقة.
5. **الاحتياجات الخاصة:** خطر متزايد (نقص الانتباه، فرط النشاط) بسبب قصر مدى الانتباه.

العامل: المركبة المسببة للإصابة أو **"الناقل"**؛ خصائصه تحدد درجة الخطورة (تصميم اللعبة، حرارة الماء، تغليف الدواء، سمية السموم).

البيئة (التصنيف): فيزيائية (هواء، سكن، ماء، تربة) · اجتماعية: **المستوى الاجتماعي** (السكن عامل خطر) · **الوقت** (أكثر الإصابات بالمنزل بين آخر العصر وأول المساء؛ صيفاً في الإجازات وعطلات الأسبوع؛ وأوقات التوتر والعجلة) · **المكان** (المنزل الأكثر شيوعاً تحت 15 سنة؛ **المطبخ والحمام الأخطر**).

Types of Accidents (4 Categories)

1 · HOME ACCIDENTS

— Falls, burns, poisoning, choking, and suffocation.

— **Choking** = an **internal** airway obstruction (like food stuck in the throat).

— **Suffocation** = an **external** one (plastic bag over mouth and nose, or chest compression).

2 · ROAD TRAFFIC ACCIDENTS

— Injuries related to **pedestrian activities, cycling, and motor vehicle incidents**.

3 · SCHOOL ACCIDENTS

— **Playground injuries**, sports-related trauma, and equipment-related falls.

4 · ENVIRONMENTAL ACCIDENTS

— **Animal bites, insect stings**, and exposure to **toxic substances**.

أنواع الحوادث (4 فئات):
1. **حوادث المنزل:** السقوط، الحروق، التسمم، الاختناق (Choking)، والخنق (Suffocation). **الاختناق = انسداد مجرى هواء داخلي** (طعام عالق بالحلق)، بينما **الخنق = انسداد خارجي** (كيس بلاستيك على الفم والأنف أو انضغاط الصدر).
2. **حوادث الطرق:** إصابات المشاة وراكبي الدراجات ومركبات السيارات.
3. **حوادث المدرسة:** إصابات الملاعب، رضوض الرياضة، والسقوط المتعلق بالمعدات.
4. **حوادث بيئية:** عضات الحيوانات، لسعات الحشرات، والتعرض للمواد السامة.

Prevention Strategies & The Nurse's 6 Roles

Effective Prevention Strategies (5)

— **1 · Parental Education:** teaching parents about **childproofing homes** and safe practices.

— **2 · Environmental Modifications:** installing **safety gates, window locks, furniture edge protectors**; keeping **hazardous substances out of reach**; ensuring **safe playgrounds and school environments**.

— **3 · Supervision:** adequate adult supervision near **water bodies, roads, and play areas**.

— **4 · Use of Safety Equipment: helmets** for cycling and skating; **car seats and seat belts** while traveling; **smoke detectors and fire extinguishers** at home.

— **5 · Public Health Policies:** implementing and enforcing laws on **traffic safety, drowning prevention, and fire safety**.

Role of the Pediatric Nurse in Accident Prevention (6)

1–3 · EDUCATION, PROGRAMS, ENVIRONMENT

— **1 · Health Education & Parental Guidance:** educate on **age-appropriate safety precautions** (childproofing, car seats, safe sleep); provide **anticipatory guidance** based on developmental milestones.

— **2 · Injury Prevention Programs:** participate in/organize **community-based programs** (drowning prevention, fire safety, helmet use, poison control); conduct **school health programs** (road & playground safety).

— **3 · Environmental Safety Measures:** ensure hospital/clinical settings are **child-friendly and hazard-free**; conduct **home safety assessments** for high-risk children (disabilities, chronic illness).

4–6 · ADVOCACY, FIRST AID, RESEARCH

— **4 · Advocacy & Policy Implementation:** support legislation for **mandatory car seats, bicycle helmets, safe playgrounds**; advocate for **improved product safety standards** (age-appropriate toys, safe household items).

— **5 · Emergency Preparedness & First Aid Training:** educate families on **basic first aid, CPR**, and emergency response (choking, burns, poisoning); train **school staff and daycare providers**.

— **6 · Research & Evidence-Based Practice:** contribute to research on **pediatric injury patterns**; implement and evaluate interventions to reduce accident-related morbidity and mortality.

استراتيجيات الوقاية الفعالة (5):
1. **تثقيف الوالدين:** تأمين المنازل والممارسات الآمنة.
2. **تعديلات بيئية:** بوابات أمان، أقفال نوافذ، واقيات حواف الأثاث، إبعاد المواد الخطرة، ملاعب ومدارس آمنة.
3. **الإشراف:** رقابة بالغين كافية قرب المياه والطرق ومناطق اللعب.
4. **معدات الأمان:** خوذات للدراجات والتزلج، مقاعد سيارات وأحزمة، كاشفات دخان وطفايات.
5. **سياسات الصحة العامة:** قوانين سلامة المرور والوقاية من الغرق والسلامة من الحريق.

دور ممرض الأطفال (6 أدوار):
1. **التثقيف الصحي والإرشاد الوالدي:** احتياطات سلامة مناسبة للعمر + **إرشاد استباقي** حسب المعالم النمائية.
2. **برامج الوقاية:** برامج مجتمعية (غرق، حريق، خوذات، سموم) + برامج مدرسية.
3. **سلامة البيئة:** أماكن رعاية آمنة خالية من المخاطر + **تقييمات سلامة منزلية** للأطفال عالي الخطورة.
4. **المناصرة والسياسات:** تشريعات مقاعد السيارات والخوذات والملاعب + معايير سلامة المنتجات.
5. **الاستعداد للطوارئ والإسعافات:** تعليم الأسر الإسعافات الأولية و**CPR** + تدريب موظفي المدارس والحضانات.
6. **البحث والممارسة القائمة على الأدلة:** أبحاث أنماط الإصابات وتقييم التدخلات.

The 3 Levels of Accident Prevention

PRIMARY — PREVENTING BEFORE OCCURRENCE

— **Goal:** Reduce risk factors and create a safe environment to **prevent accidents from happening in the first place**.

— **Parental Education:** securing furniture, covering electrical outlets, using baby gates.

— **Safety Equipment Use:** car seats, booster seats, bicycle helmets, smoke detectors, childproof locks.

— **Legislation & Policies:** seatbelt use, helmet requirements, **pool fencing** to reduce drowning.

— **Community Awareness Campaigns:** workshops on fire safety, poison prevention, fall prevention.

— **Safe School & Playground Design:** soft surfaces and age-appropriate equipment.

SECONDARY — EARLY DETECTION & IMMEDIATE INTERVENTION

— **Goal: Minimize harm** by detecting and responding quickly to accidents when they occur.

— **First Aid & CPR Training:** for parents, teachers, caregivers (choking, burns, falls).

— **Early Screening for Risk Factors:** identifying high-risk children (hyperactive, mobility impairments) + additional safety measures.

— **Emergency Response Systems:** awareness of emergency contact numbers & quick access to healthcare.

— **Immediate Medical Attention:** timely treatment to prevent complications (e.g., treating minor burns before they worsen).

TERTIARY — REDUCING LONG-TERM CONSEQUENCES

— **Goal: Minimize disability, improve recovery**, and prevent future complications after an accident has occurred.

— **Rehabilitation Services:** physical therapy for fractures, burns, head injuries.

— **Psychological Support:** counseling for traumatic accidents to prevent emotional distress and anxiety.

— **Assistive Devices & Modifications:** mobility aids, prosthetics, adaptive equipment for permanent disabilities.

— **Safety Re-evaluation:** identifying the cause and implementing stronger measures to avoid recurrence.

💎 QUICK DISCRIMINATOR

— **Primary** = stop it from happening (gates, helmets, laws).

— **Secondary** = act fast when it happens (first aid, CPR, emergency response).

— **Tertiary** = heal & prevent sequelae (rehab, counseling, prosthetics).

مستويات الوقاية الثلاثة:
الأولية (قبل الحدوث): الهدف تقليل عوامل الخطر وخلق بيئة آمنة **لمنع الحوادث من الأساس** · تثقيف الوالدين (تثبيت الأثاث، تغطية الكهربائيات، بوابات) · معدات الأمان (مقاعد سيارات، خوذات، كاشفات دخان) · تشريعات (أحزمة، خوذات، **أسوار حمامات السباحة**) · حملات توعية · تصميم مدارس وملاعب آمنة.

الثانوية (الكشف المبكر والتدخل الفوري): الهدف **تقليل الضرر** بالاستجابة السريعة · تدريب الإسعافات و**CPR** · فحص مبكر لعوامل الخطر (الأطفال مفرطي النشاط) · أنظمة استجابة طارئة · عناية طبية فورية (علاج الحروق البسيطة قبل تفاقمها).

الثالثية (تقليل العواقب طويلة المدى): الهدف **تقليل الإعاقة وتحسين التعافي** · خدمات تأهيل (علاج طبيعي للكسور والحروق) · دعم نفسي (إرشاد بعد الصدمات) · أجهزة مساعدة وتعديلات (أطراف صناعية) · إعادة تقييم السلامة لمنع التكرار.

Quick Revision & Final Recap

Critical Numbers to Memorize

ITEM	VALUE
Global injury deaths/year	**4.4 million ≈ 8%** of all deaths
Years lived with disability from injuries	**10%**
Ages 5–29: injury-related top-5 deaths	**3 of the top 5**
Leading cause of death	Over **1 year** & adolescents = accidents; under **19** = injuries
UN IGME deaths 2020	**>5 M** under-5 (2.4 M newborns) + **2.2 M** aged 5–24 (43% adolescents)
Egypt under-5 mortality	**18.1 / 1000** live births; peak injuries **2–6 yrs**; boys > girls
Hospitalization share	**>23%** admissions · **28%** ED visits (under 15)
Male vs female injury death rate	Male = **twice** female
Epi model / Host factors / Accident types	**3** factors · **5** host characteristics · **4** types
Prevention strategies / Nurse roles / Levels	**5** strategies · **6** nurse roles · **3** levels

Common Confusions — Clear Answers

YOU MIGHT THINK…	BUT ACTUALLY…
Choking = suffocation	**Choking = internal** airway obstruction (food in throat); **suffocation = external** (plastic bag, chest compression).
Injury = wound	**All wounds are injuries, but not all injuries are wounds.** Injury is **closed**; wound is **opened** (blood drawn).
Impairment = disability = handicapping	**Impairment** = lost/defective limb or organ · **Disability** = loss/reduction of function · **Handicapping** = restriction of activity **forever**.
Accidents cannot be avoided	**Injuries are not "accidents" — injuries can be prevented** (education, supervision, safety regulations).
First aid is primary prevention	First aid & CPR are **secondary** prevention; primary = gates, helmets, laws; tertiary = rehab & counseling.

💎 **In one sentence:** Accidents are the leading killer of children after one year, but through the epidemiological lens (host–agent–environment), five prevention strategies, six nursing roles, and three prevention levels, nearly every childhood injury becomes a preventable event.

💎 **في جملة واحدة:**
الحوادث هي القاتل الأول للأطفال بعد السنة الأولى، لكن عبر العدسة الوبائية (مضيف–عامل–بيئة)، وخمس استراتيجيات وقاية، وستة أدوار تمريضية، وثلاثة مستويات وقاية، تصبح تقريباً كل إصابة طفل حدثاً يمكن منعه.

Expected Exam MCQs

📌 **Note:** The source lecture does not include self-evaluation questions. The following are **AI-generated** strictly from the lecture content for revision.

1 AI **Accidents are the main cause of all deaths in which group?**

- a) Infants under 1 year
- **b) Children over one year and adolescents ✓**
- c) Neonates only
- d) Adults over 40

AIالإجابة: b — الحوادث السبب الرئيسي لكل الوفيات في الأطفال فوق السنة والمراهقين.

2 AI **Choking is best described as:**

- **a) An internal airway obstruction (food stuck in the throat) ✓**
- b) An external obstruction like a plastic bag
- c) Chest compression
- d) Drowning in shallow water

AIالإجابة: a — الاختناق (Choking) انسداد داخلي، أما الخنق (Suffocation) فخارجي.

3 AI **"All wounds are injuries, but not all injuries are wounds" because:**

- a) Wounds are closed and injuries are opened
- **b) Injury is closed; wound is opened (blood drawn) ✓**
- c) Injuries only result from violence
- d) Wounds never result from accidents

AIالإجابة: b — الإصابة مغلقة والجرح مفتوح (لا يصبح جرحاً إلا عند سفك الدم).

4 AI **The epidemiological model of accident prevention includes:**

- **a) Host, agent, and environment ✓**
- b) Child, parent, and nurse
- c) Time, place, and person
- d) Injury, impairment, and disability

AIالإجابة: a — المضيف (الطفل)، العامل (سبب الإصابة)، والبيئة (المحيط).

5 AI **Which of the following is NOT a host factor in the epidemiological model?**

- ◯ a) Age / developmental level
- ◯ b) Curiosity
- ◯ c) Peer pressure
- ◯ **d) Toy design ✓**

AIالإجابة: d — تصميم اللعبة من خصائص العامل (Agent) وليس المضيف.

6 AI **Most childhood injuries at home occur:**

- ◯ a) Early morning before school
- ◯ **b) Between late afternoon and early evening ✓**
- ◯ c) At midnight only
- ◯ d) During winter holidays only

AIالإجابة: b — أكثر الإصابات المنزلية بين آخر العصر وأول المساء، وصيفاً في الإجازات وعطلات الأسبوع.

7 AI **Providing rehabilitation services and psychological support after an accident belongs to:**

- ◯ a) Primary prevention
- ◯ b) Secondary prevention
- ◯ **c) Tertiary prevention ✓**
- ◯ d) Primordial prevention

AIالإجابة: c — التأهيل والدعم النفسي من الوقاية الثالثية (تقليل العواقب طويلة المدى).

8 AI **In Egypt, which of the following is NOT among the five main causes of childhood injuries?**

- ◯ a) Wounds and fractures
- ◯ b) Burns
- ◯ **c) Drowning ✓**
- ◯ d) Swallowing a foreign body / ingesting poison

AIالإجابة: c — الخمسة الرئيسية: جروح، كسور، حروق، بلع جسم غريب، ابتلاع سم. الغرق أكثر في الريف لكنه ليس من الخمسة.

Conclusion, Duas After Studying & Closing

Conclusion (from the source): Accident prevention in pediatrics is crucial to reducing injuries and fatalities. By understanding risk factors and implementing effective safety measures, parents, caregivers, and policymakers can create a safer environment for children. **Education, supervision, and safety regulations** play a vital role in minimizing accidents and ensuring child well-being.

الخاتمة (من المصدر):

- الوقاية من الحوادث في طب الأطفال ضرورية لتقليل الإصابات والوفيات.
- بفهم عوامل الخطر وتطبيق تدابير سلامة فعالة، يستطيع الوالدان ومقدمو الرعاية وصناع السياسات خلق بيئة أكثر أماناً للأطفال.
- **التعليم والإشراف ولوائح السلامة** تلعب دوراً حيوياً في تقليل الحوادث وضمان رفاهية الطفل.

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

🤍 **ختاماً:** نسأل الله أن يجعله **علماً نافعاً** تنفع به نفسك ومرضاك، وأن يحفظك وأهلك من كل سوء ومكروه، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة التي ترضاها يا رب العالمين. آمين 🌿